

פרק 19

הטיפול ביתר לחץ דם בבית החולים ובמצבי חירום של יתר לחץ דם

פרופ' עידו בן-דב

פרופ' טליה וולק

לפני הקדמה

יתר לחץ דם גבוה אסימפטומטי, כולל ערכים חמורים ($\leq 180/110$ מ"מ"כ), אינו מהווה אינדיקציה לשליחת המטופל לחדר המיון. הפנייה לחדר המיון במצבים אלו חושפת את המטופל לסיכונים (כולל הורדה מהירה ולא מבוקרת של ל"ד) ללא תועלת מוכחת. הכלל המנחה הוא: אם המטופל אסימפטומטי - אין עדות קלינית לנזק חריף לאברי מטרה - הטיפול המתאים הוא אמבולטורי. יש להעריך את המטופל במרפאת הרופא המטפל או במרפאת יל"ד, לברר את הגורם לעלייה בל"ד, ולהתאים את הטיפול - ללא דחיפות של שעות. מתי כן לשלוח לחדר המיון? בנוכחות תסמינים או ממצאים המחשידים לנזק חריף לאברי מטרה: כאבים בחזה, קוצר נשימה, כאב ראש פתאומי וחמור, שינויים נוירולוגיים חדשים (חולשה, הפרעות ראייה, קשיי דיבור), בלבול, או רמזים לפגיעה כלייתית (אפשר להיעזר בסטיק שתן).

הקדמה

ניהול יל"ד בחדר המיון ובמהלך אשפוז מהווה אתגר קלינאי משמעותי. למרות קיומן של הנחיות ברורות לטיפול ביל"ד במסגרת אמבולטורית, ופחות מכך לגבי מצבים דחופים בחדר המיון, אין כיום הנחיות מבוססות ראיות לניהול יל"ד אסימפטומטי בחולים מאושפדים. ממצא זה תועד בסקירה שיטתית שפורסמה ב-2024 בכתב העת Annals of Internal Medicine, אשר בחנה 14 הנחיות בינלאומיות לטיפול ביל"ד ומצאה כי אף אחת מההנחיות לא סיפקה המלצות לניהול עליית ל"ד אסימפטומטית באשפוז.

עובדות חשובות:

- 50-72% מהמאושפדים מציגים ערכי ל"ד העולים על הסף המקובל במתאר האמבולטורי
 - 21-34% מהמאושפדים מקבלים תרופות להורדת ל"ד תוך-וריד
 - 9-14% משוחררים עם תוספת תרופות אנטי-היפרטנסיביות חדשות
 - אין מחקרים אקראיים המוכיחים תועלת מטיפול אגרסיבי ביל"ד במהלך אשפוז
 - מחקרים תצפיתיים מצביעים על סיכון מוגבר ל-AKI, שבץ ופגיעה מיוקרדיאלית בעקבות טיפול אינטנסיבי.
- פרק זה מתמקד בהנחיות לטיפול במצבי חירום ביתר לחץ דם, ובסקירה לגבי הטיפול ביל"ד אסימפטומטי במהלך אשפוז.

מונחים והגדרות עדכניות (2026)

1. יל"ד חמור אסימפטומטי (Severe Asymptomatic Hypertension)

הגדרה מומלצת מעדכנת:

- ל"ד מ-120/110-180 מ"מ"כ ומעלה
- ללא תסמינים
- ללא עדות לנזק חריף לאברי מטר

מונח זה מועדף על "Hypertensive Urgency" שכן המונח הישן מטעה - במרבית המקרים אין דחיפות אמיתית לטיפול מיידי.

2. מצב חירום של יל"ד (Hypertensive Emergency)

הגדרה:

- ל"ד חמור (בדרך כלל 180/120 מ"מ"כ ומעלה, אך לא תמיד)
- בנוכחות נזק חריף מתקדם לאיבר מטר
- הסימפטומים והנזק לאיברי מטר חשובים יותר מערכי היל"ד המדויקים

מצבי חירום מוכרים:

פגיעה קרדיווסקולרית:

- תסמונת כלילית חריפה (אוטם שריר הלב, תעוקת חזה לא יציבה)
- אי-ספיקת לב חריפה / בצקת ריאות
- דיסקציה אאורטלית

פגיעה נוירולוגית:

- אנצפלופתיה היפרטנסיונית
- שבץ מוחי דימומי (ICH, SAH)
- שבץ מוחי איסכמי (במקרים נבחרים)

פגיעה כלייתית:

- אי-ספיקת כליות חריפה על רקע יל"ד ממאיר
- מיקרואנגיופתיה טרומבוטית

פגיעה בעיניים:

- רטינופתיה היפרטנסיונית דרגה IV (פפילאדמה)
- דימומים ברשתית

מצבים מיוחדים:

- פרהאקלמפסיה / אקלמפסיה
- משבר פאוכרומוציטומה
- משבר סקלרודרמה כלייתי

עקרונות מנחים לטיפול ביל"ד בבית החולים

זיהוי מול אי-זיהוי חירום



"ראשית - אל תזיק" (Primum Non Nocere)

הוכח כי הורדה מהירה ולא מבוקרת של ל"ד עלולה לגרום נזק.

סיכונים של טיפול אגרסיבי מידי:

1. איסכמיה מוחית - פגיעה באוטורגולציה של זרימת הדם המוחי
2. איסכמיה קורונרית - ירידה בזילוח הכלילי, בעיקר בדיאסטולה
3. AKI (Acute Kidney Injury) - ירידה חדה ב-GFR
4. תת-לחץ דם אורטוסטטי - סינקופה, נפילות
5. תופעות לוואי תרופתיות

מחקרים תצפיתיים מצביעים על כך שחולים שקיבלו תרופות IV לל"ד במהלך אשפוז לא-קרדיולוגי הציגו שיעורי תמותה ותחלואה גבוהים יותר, ושחולים ששוחררו עם תוספת תרופות לל"ד לא הראו שיפור בתוצאים קרדיווסקולריים.

הבנת הפיזיולוגיה של עליית ל"ד באשפוז

ל"ד עשוי לעלות באשפוז כתגובה פיזיולוגית ל:

- כאב
 - חרדה ומתח
 - טמפרטורה (חום)
 - אנמיה
 - היפוקסיה
 - היפרקפניה
 - שלפוחית שתן מלאה
 - חוסר שינה
 - גמילה מתרופות (clonidine, beta-blockers)
 - תרופות מעלות ל"ד (NSAIDs, סטרואידים)
- גישה נכונה: טיפול בגורם הבסיסי, לא רק בעליית הלחץ הדם

ניהול יל"ד חמור

לפני כל החלטה טיפולית - יש לוודא טכניקת מדידה נכונה, מדידות חוזרות. יש לחפש סיבות הפיכות לעליית לחץ הדם.

דוגמאות לסיבות הפיכות:

- האם החולה סובל מכאב?
- האם החולה חרד?
- האם שלפוחית השתן מלאה?
- האם החולה קיבל NSAIDs / סטרואידים?
- האם הופסקו תרופות אנטי-היפרטנסיביות?
- האם מצב המחלה חריף (חום, אנמיה, היפוקסיה)?

יש לחפש סימנים לפגיעה באברי מטרה (הדורשים בירור וטיפול בדחיפות) אם לחולה תלונות מדאיגות, ל"ד $\geq 200/120$ ממ"מ באופן עקבי, או החולה בסיכון גבוה (היסטוריה של CVA, MI, CKD). **הבדיקות המומלצות** (בהתאם לקליניקה): בדיקה גופנית ממוקדת, סימנים חיוניים חוזרים, בדיקת קרקעית העין (fundoscopy). **בדיקות מעבדה** (לפי חשד): כימיה: אוריאאה, קריאטינין, אלקטרוליטים, טרופונין, שתן מלא + יחס אלבומין/קריאטינין, ספירת דם (אנמיה? תרומבוציטופניה?), LDH (חשד למיקרואנגיופטיה). **בדיקות הדמיה** (לפי אינדיקציה קלינית): אק"ג - בחשד לפגיעה לבבית, צילום חזה - אם קיים קוצר נשימה / חשד לבצקת ריאות, CT ראש - אם ישנם ממצאים נירולוגיים חדשים, אקו לב - אם קיים חשד לאי-ספיקת לב חריפה / דיסקציה, CT אנגיוגרפיה - אם חשד חזק לדיסקציה.

טיפול ביל"ד חמור אסימפטומטי

אין הצדקה לטיפול דחוף במרבית המקרים. עקרונות הטיפול:

לא לטפל תוך ורידי

- אין מקום לתרופות IV בחולה אסימפטומטי
- אין מקום ל-"Pro Re Nata" (PRN) orders אוטומטיים של hydralazine או labetalol IV
- הורדה מהירה מדי מסוכנת!
- As Needed - Pro Re Nata *

טיפול בסיבה הבסיסית:

- טיפול בכאב
- טיפול בחרדה
- החזרת תרופות שהופסקו
- הפסקת תרופות מעלות ל"ד

אופציות טיפול פומי:

- ACE inhibitor (למשל: enalapril 10 mg)
- ARB (למשל: losartan 50 mg)
- CCB (למשל: lercanidipine 10 mg)
- Beta-blocker (למשל: labetalol 100-200 mg PO)
- Alpha-blocker (למשל: doxazosin 1-2 mg)

יעד הטיפול:

- הפחתה של 10-20% בל"ד תוך 24-48 שעות
- לא יעד ספציפי של מספר מסוים

מעקב:

- בדיקת ל"ד חוזרת לאחר 2-4 שעות מתחילת הטיפול
- מעקב אחר תסמינים של תת לחץ דם
- התאמת הטיפול הביתי לקראת שחרור

מתי לא לטפל בכלל?

במצבים הבאים יש לשקול לוותר על טיפול תרופתי:

1. חולה במצב סופני (hospice, comfort care)
2. חולה שביר מאוד עם orthostatic hypotension
3. שבץ איסכמי חריף (ראו להלן)

4. חולה לא משתף פעולה עם מדידות לא אמינות
5. עלייה חולפת בעקבות מתח חריף (ניתוח, בדיקה פולשנית)
6. חולה עם דמנציה מתקדמת - לשקול יעדים מותאמים אישית

טיפול במצבי חירום של ל"ד

עקרונות כלליים

מצב חירום = אשפוז + ניטור צמוד + שימוש בתרופות IV

מיקום הטיפול:

- ICU או יחידה קורונרית במרבית המקרים
- יחידת ביניים במחלקה פנימית - במקרים נבחרים עם חולה יציב יחסית

עקרונות הורדת ל"ד:

אין להוריד את ל"ד מהר מדי פרט לדיסקציה אאורטלית.

יעדים כלליים:

- הפחתה של 20-25% ב-MAP תוך השעה הראשונה
- הגעה לערכים של 110-160/100 מ"מ תוך 2-6 שעות
- הגעה ליעד הסופי תוך 24-48 שעות
- חריגה: דיסקציה אאורטלית - הפחתה מיידית ל- ≥ 120 מ"מ סיסטולי

טיפול לפי מצב חירום ספציפי

1. דיסקציה אאורטלית (Aortic Dissection)

יעדים:

- $SBP \leq 120$ מ"מ - בהקדם האפשרי
- Heart rate < 60 bpm (להפחית shear stress)
- Beta-blocker IV (להפחית HR במקביל להפחתת BP)
- Esmolol IV: בולוס 0.5-1 mg/kg, אח"כ 50-300 mcg/kg/min
- Labetalol IV: 20-80 mg bolus, אח"כ 1-2 mg/min
- Metoprolol IV: 5 mg כל 5 דקות (עד 15 mg)
- לאחר מכן - וזודילטור:
- Nicardipine IV: 5-15 mg/hr
- Nitroprusside IV: 0.3-10 mcg/kg/min (זהירות מציאנוטוקסיות)

2. תסמונת כלילית חריפה (ACS)

יעדים:

- הפחתה ב-25% תוך השעה הראשונה
- יעד: 160/100 מ"מ"ס תוך מספר שעות
- Nitroglycerin IV: התחל ב-5-10 mcg/min, העלה כל 5 דקות
 - מפחית preload
 - מרחיב עורקים כלילים
 - יעיל לבצקת ריאות
- Labetalol IV / Esmolol IV
 - אם אין התוויות נגד (AV block, ברונוספזם)
 - מפחית HR וצריכת חמצן מיוקרדיאלית

3. בצקת ריאות / אי-ספיקת לב חריפה

יעדים:

- הפחתה של 25% ב-MAP תוך השעה הראשונה
- Nitroglycerin IV או Nitroprusside IV
- הפחתת preload ו-after load
- שיפור בתפוקה הלבבית
- Loop diuretics
- Furosemide IV: 40-80 mg (או מינון גבוה יותר לפי הצורך)

טיפול נוסף:

- Morphine - זהירות! (סיכון לדיכוי נשימתי)
- BiPAP / CPAP - משפר חמצון
- טיפול ב-Beta-blockers לא מתאים בשלב החריף (למעט מצבים נבחרים)

4. אנצפלופתיה היפרטנסיבית

קריטריונים לאבחנה:

- ל"ד חמור
- שינוי במצב ההכרה, בלבול, הקאות, פרכוס
- ההפרעות ראייה
- לעתים פפילאדמה

הדמייה: שלילת דימום מוחי ב- CT או ב- MRI ולצורך אבחנה של PRES
(Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome)

יעדים:

- הפחתה של 20-25% ב- MAP תוך השעה הראשונה
- 160/100 ממ"מ תוך 2-6 שעות

טיפול קו ראשון:

- Nicardipine IV: 5-15 mg/hr
- Labetalol IV: 20-80 mg boluses / infusion

חלופות:

- Nitroprusside - רק תחת ניטור ICU צמוד

5. שבץ מוחי דימומי (ICH / SAH)

גישה עדכנית (2024-2025):

ICH חריף:

- אם לחץ הדם מעל 220 ממ"מ, ניתן להוריד ל 180 ממ"מ.
- אם לחץ הדם מתחת ל 220 ממ"מ, כדאי להפחית ל 140 ממ"מ.
- במקרים נבחרים (ICH קטן, ללא IVH): שקלו יעד >140 ממ"מ

:SAH

- יעד SBP: 140-160 ממ"מ לפני אבטחת מפרצת (securing aneurysm)
- לאחר טיפול במפרצת: לשקול יעד >180 ממ"מ

תרופות מומלצות:

- Nicardipine IV
- Labetalol IV

6. שבץ מוחי איסכמי חריף

עקרון מרכזי: לא להוריד ל"ד ביתר. עלייה בל"ד היא מנגנון הגנתי למוח האיסכמי (autoregulation).

הנחיות עדכניות (AHA/ASA 2024-2025):

מועמדים לתרומבוליה:

- לא להוריד ל"ד אם SBP <185 ו DBP <110
- אם SBP ≥185 או DBP ≥110:
 - לטפו בזירות להגיע ל- >185/110
 - תרופות: labetalol IV או nicardipine IV

- לאחר תרומבוליזה: לשמור על $180/105$ למשך 24 שעות

לא מועמדים לתרומבוליזה:

- אם $SBP > 220$ או $DBP > 120$: לשקול הפחתה זהירה ב-15%
- ברוב המקרים לא לטפל ביל"ד ב-24-48 השעות הראשונות.

טיפול ארוך-טווח:

- להחזיר תרופות ליל"ד לאחר 48-72 שעות מהשבץ
- יעד ארוך טווח: $130/80$ מ"מ"כ

7. פרהאקלמפסיה / אקלמפסיה חמורה (ראה/י פרק נפרד)

יעדים:

- $SBP < 160$ מ"מ"כ
- $DBP < 105$ מ"מ"כ

טיפול:

1. Magnesium sulfate IV (למניעת פרכוסים)

◦ Bolus: 4-6 g IV תוך 15-20 דק'

◦ Maintenance: 1-2 g/hr

2. Labetalol IV

◦ 20 mg IV, אח"כ 40-80 mg כל 10 דקות

◦ או infusion: 1-2 mg/min

3. Nicardipine IV (חלופה):

◦ 5-10 mg/hr

התוויות נגד:

- ACE inhibitors / ARBs (טרטוגניים!)
- Nitroprusside (רעילות לעובר)

טיפול סופי: לידה!

8. אי-ספיקת כליות חריפה / יל"ד ממאיר

מאפיינים:

- עליית קריאטינין חריפה
- המטוריה / פרוטאינוריה
- מיקרואנגיופתיה (schistocytes, anemia, thrombocytopenia)

יעדים:

הפחתה הדרגתית ב-25% תוך 24-48 שעות

טיפול:

- Nicardipine IV
- Labetalol IV
- לרוב לא ACE/ARB בשלב החריף (עלולים להחמיר את תפקוד הכליות)
- לשקול דיאליזה במקרים חמורים

טבלה מסכמת: תרופות IV לחירומי יל"ד

תרופה	מנגנון	מינון	התחלת פעולה	משך פעולה	שימוש מועדף	התוויות נגד / זהירות
Nicardipine	CCB	5-15 mg/hr	5-10 דק'	3-4 שעות	רוב המצבים (קו ראשון!)	הפטוטוקסיות, stenosis אאורטלי
Labetalol	Alpha+Beta blocker	20-80 mg bolus / 1-2 mg/min inf	5-10 דק'	3-6 שעות	רוב המצבים, טוב למוח	אסטמה, heart block, ברדיקרדיה, HFrEF
Esmolol	Beta-1 blocker	Bolus 0.5-1 mg/kg → 50-300 mcg/kg/min	1-2 דק'	10-30 דק'	דיסקציה אאורטלית, ACS	אסטמה, heart block, HFrEF
Nitroglycerin	Nitrate	5-200 mcg/min	2-5 דק'	5-10 דק'	ACS , בצקת ריאות	Hypotension, right ventricular MI
Nitroprusside	NO donor	0.3-10 mcg/kg/min	מידי	2-5 דק'	כשל כל השאר	AKI, ICH, רעילות ציאניד (>48 שעות)
Hydralazine	Vasodilator	10-20 mg IV	10-20 דק'	3-8 שעות	פראקלמפ סיה בלבד	דיסקציה, ACS, טניקרדיה

מה לא לעשות - טעויות נפוצות

טעות: שימוש אוטומטי ב-PRN orders

בעייתי:

"Hydralazine 10 mg IV PRN for SBP >160"

"Labetalol 20 mg IV PRN for SBP >180"

מוביל לטיפול לא מושכל ללא הערכה קלינית

מתעלם מסיבות הבסיסיות

גורם להורדה לא מבוקרת של ל"ד

במקום זאת: הוראה ספציפית לפי מצב קליני מוגדר

טעות: "טיפול בערכים" במקום "טיפול בחולה"

בעיית: טיפול בל"ד 180/100 בחולה ישן בשלווה

טעות: טיפול בשבץ איסכמי כאילו זה שבץ דימומי

שבץ איסכמי ≠ שבץ דימומי

בשבץ איסכמי: ל"ד גבוה = מנגנון הגנתי → לא להוריד ביתר

טעות: הוספת תרופות לטווח ארוך ללא תכנון

טעות: Hydralazine IV נקו ראשון

- עלייה רפלקסיבית ב-HR
- הורדה לא צפויה של ל"ד
- משך פעולה ארוך (קשה לשלוט)

מתי בכלל להשתמש?

- בפרהאקלמפסיה/אקלמפסיה
- אחרי מגנזיום

המעבר מבית החולים לקהילה

האתגר: אין הנחיות לניהול המעבר של חולה עם יל"ד מבית החולים לקהילה

בעיות נפוצות:

1. חולים משוחררים עם תוספות תרופות מיותרות
2. חולים משוחררים ללא תכנון מעקב ברור
3. תיעוד לא מספיק ברור במכתב השחרור
4. היעדר הדרכה על HBPM

המלצות לשחרור חולה

שלב 1: החלטה - האם יש לשנות טיפול תרופתי?

שאלות מנחות:

- האם ל"ד של החולה היה גבוה באופן עקבי לפני האשפוז?
- האם יש תיעוד של HBPM/ABPM מחוץ לבית החולים?

- האם החולה נטל תרופות בהתאמה לפני האשפוז?
- האם עלית ל"ד באשפוז נבעה מגורם חולף (כאב, ניתוח)?

שלב 2: תכנון השחרור

במכתב השחרור - רשמו בבירור:

כותרת "שינויים בטיפול התרופתי ליל"ד":

- להפסיק: [שם תרופה] - סיבה: [למשל: גרמה להיפוקלמיה]
- להתחיל: [שם תרופה, מינון] - סיבה: [למשל: יל"ד לא מאוזן קודם לאשפוז]
- להמשיך: [שם תרופה, מינון] - ללא שינוי
- לשקול התאמה: [שם תרופה] - יש לבדוק קריאטינין/K+ בעוד שבוע

שלב 3: הדרכת החולה

נושאים להדרכה:

מדידת ל"ד בבית (HBPM):

- איך למדוד נכון
- מתי למדוד (בוקר וערב)
- כמה ימים (3-7 ימים)
- איך לתעד (יומן)

יעדי הטיפול:

- יעד ל"ד ביתי: $>130/80$ מ"מ"כ
- יעד ל"ד במרפאה: $>130/80$ מ"מ"כ

מתי לפנות לטיפול דחוף:

- כאב חזה
- קוצר נשימה
- כאב ראש חמור
- חולשה / שינוי בדיבור / הפרעות ראייה
- לא רק ל"ד גבוה

תופעות לוואי של תרופות חדשות:

- סחרחורת / סינקופה
- בצקות ברגליים (CCB)
- שיעול יבש (ACE-I)

שלב 4: תכנון המעקב**מי ומתי?****חולה עם שינוי תרופתי משמעותי:**

- מעקב אצל רופא המשפחה תוך 1-2 שבועות
- בדיקות דם (קריאטינין, אלקטרוליטים) תוך שבוע
- HBPM למשך 3-7 ימים לפני הביקור

חולה ללא שינוי תרופתי:

- מעקב שגרתי לפי התכנית הקודמת

חולה עם יל"ד לא מאוזן קודם לאשפוז:

- שקלו הפניה למרפאת יל"ד / נפרולוגיה

שלב 5: שימוש ב-HBPM לאחר שחרור**המלצה: כל חולה ששוחרר עם שינוי תרופתי צריך HBPM****יתרונות:**

- זיהוי תת-לחץ דם מוקדם
- אימות שהשינוי התרופתי מועיל
- מניעת ביקורי חירום מיותרים
- מניעת over treatment

ביבליוגרפיה עדכנית**הנחיות עדכניות (2023-2025)**

1. Wilson LM, Herzig SJ, Steinman MA, et al. Management of Inpatient Elevated Blood Pressures: A Systematic Review of Clinical Practice Guidelines. Ann Intern Med. 2024; 177:497-506.
2. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, et al. 2023 ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens. 2023; 41:1874-2071.
3. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension. Eur Heart J. 2024; 45:3912-4018.
4. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. 2025 AHA/ACC Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension. 2025;82: e212-e316.
5. Kulkarni S, Glover M, Kapil V, et al. Management of Hypertensive Crisis: British and Irish Hypertension Society Position Document. J Hum Hypertens. 2022; 37:863-879.

מחקרים על יל"ד באשפוז

6. **Anderson TS, Herzig SJ, Jing B, et al.** Clinical Outcomes of Intensive Inpatient Blood Pressure Management in Hospitalized Older Adults. *JAMA Intern Med.* 2023; 183:715-723.
7. **Rastogi R, Sheehan MM, Hu B, et al.** Treatment and Outcomes of Inpatient Hypertension Among Adults with Noncardiac Admissions. *JAMA Intern Med.* 2021; 181:345-352.
8. **Ghazi L, Li F, Simonov M, et al.** Effect of Intravenous Antihypertensives on Outcomes of Severe Hypertension in Hospitalized Patients Without Acute Target Organ Damage. *J Hypertens.* 2023; 41:288-294.
9. **Axon RN, Cousineau L, Egan BM.** Prevalence and Management of Hypertension in the Inpatient Setting: A Systematic Review. *J Hosp Med.* 2011; 6:417-422.

הנחיות לטיפול בשבץ

10. **Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al.** Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke: 2019 Update. *Stroke.* 2019;50: e344-e418.
11. **Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al.** 2022 Guideline for the Management of Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. *Stroke.* 2022;53: e282-e361.

מאמרי דעה חשובים

12. **Anderson TS, Wray CM.** Inpatient Hypertension—To Treat or Tolerate? *Ann Intern Med.* 2020;172: H02-H03.
13. **Jacobs ZG.** Hypertensive "Urgency" Is a Harmful Misnomer. *J Gen Intern Med.* 2021; 36:2812-2813.
14. **Weder AB.** Treating Acute Hypertension in the Hospital: A Lacuna in the Guidelines. *Hypertension.* 2011; 57:18-20.